

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Dyspnée / Désaturation

Conduite à tenir devant gêne respiratoire ou baisse de saturation, avec priorisation de la sécurité et de l'alerte.

Indications

- Dyspnée, polypnée, cyanose, agitation ou difficulté à parler.
- Désaturation mesurée ou suspectée.
- Tableau respiratoire aigu nécessitant évaluation immédiate.

Vérifications préalables

- Installer en position demi-assise si tolérée.
- Mesurer saturation, fréquence respiratoire et paramètres si possible.
- Rechercher encombrement, douleur thoracique, fièvre ou bronchospasme connu.
- Vérifier oxygène ou traitement inhalé prescrit/protocolisé.

Ne pas appliquer ce protocole

- Ne pas retarder l'appel au secours en cas de détresse.
- Ne pas administrer de bronchodilatateur sans prescription individualisée.
- Ne pas laisser le résident seul.
- Ne pas banaliser une désaturation persistante.

Conduite à tenir

- Surveiller en continu jusqu'à amélioration ou relai médical.
- Oxygène uniquement selon prescription, protocole local validé ou consigne médicale.
- Traitement inhalé uniquement si prescription nominative ou protocole validé.
- Prévenir immédiatement IDE/médecin devant toute gêne respiratoire aiguë.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure, SpO2, fréquence respiratoire, signes et mesures prises.
- Réévaluer tolérance, coloration, conscience et efficacité des mesures.
- Noter appel médical ou SAMU.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si dyspnée nouvelle, désaturation persistante ou fièvre mal tolérée.
- Appel 15 si cyanose, impossibilité de parler, trouble de conscience, douleur thoracique ou SpO2 très basse persistante.

Mention de sécurité

Ce protocole ne remplace pas une prescription individualisée d'oxygène ou de bronchodilatateur. Priorité : sécuriser, évaluer, alerter.

Fait à :

Le : / /

Signature :